Pergunta

Flashcard

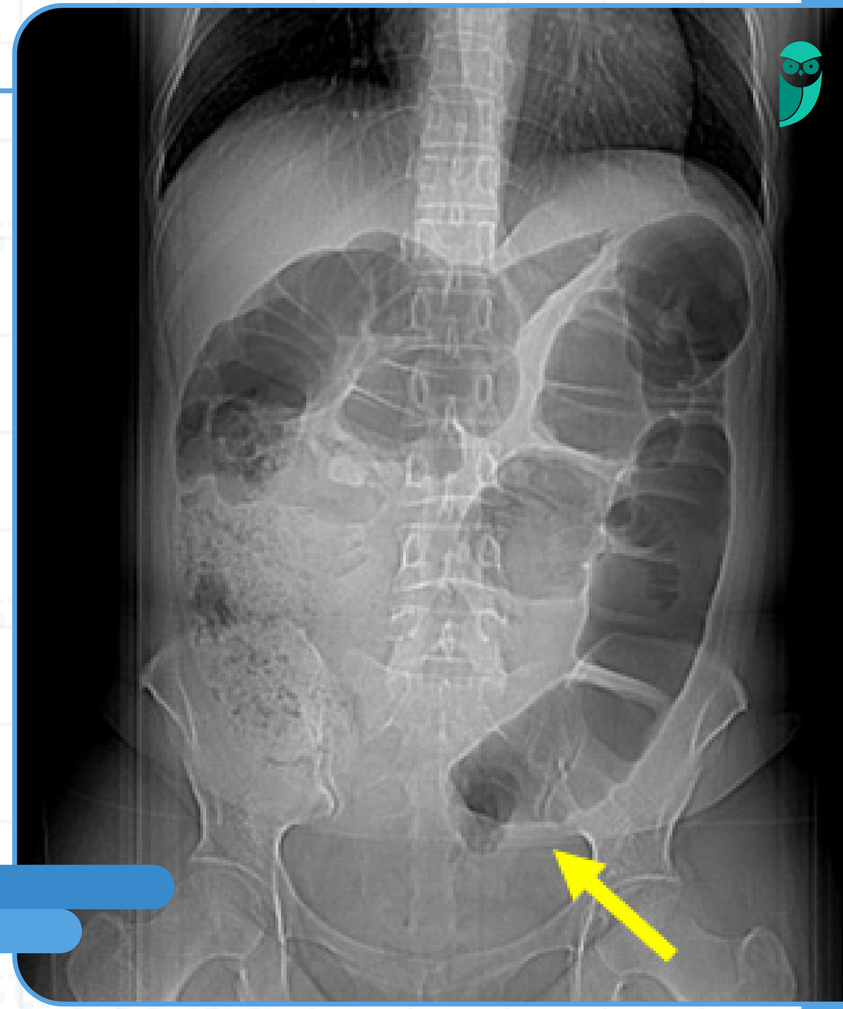
O que é uma obstrução intestinal em alça fechada?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Obstrução em dois pontos do intestino, o que impede a drenagem por vômitos e por evacuação, podendo causar distensão, isquemia, necrose,perfusão e peritonite. Ocorre, por exemplo, na neoplasia obstrutiva de cólon sigmoide com válvula ileocecal competente.



Pergunta

Flashcard

Qual é a classificação do abdome agudo obstrutivo quanto à localização?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

- Obstrução alta: obstruções proximais à válvula ileocecal (p. ex.: as causadas por bridas intestinais);
- Obstrução baixa: obstruções distais à válvula ileocecal (p. ex.: neoplasias colorretais ou volvo de sigmoide).

Pergunta

Flashcard

Quais são os sintomas típicos do abdome agudo obstrutivo?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Dor, distensão abdominal, vômitos e parada de eliminação de fezes e flatos.

Pergunta

Flashcard

Quais são os exames da rotina de abdome agudo?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

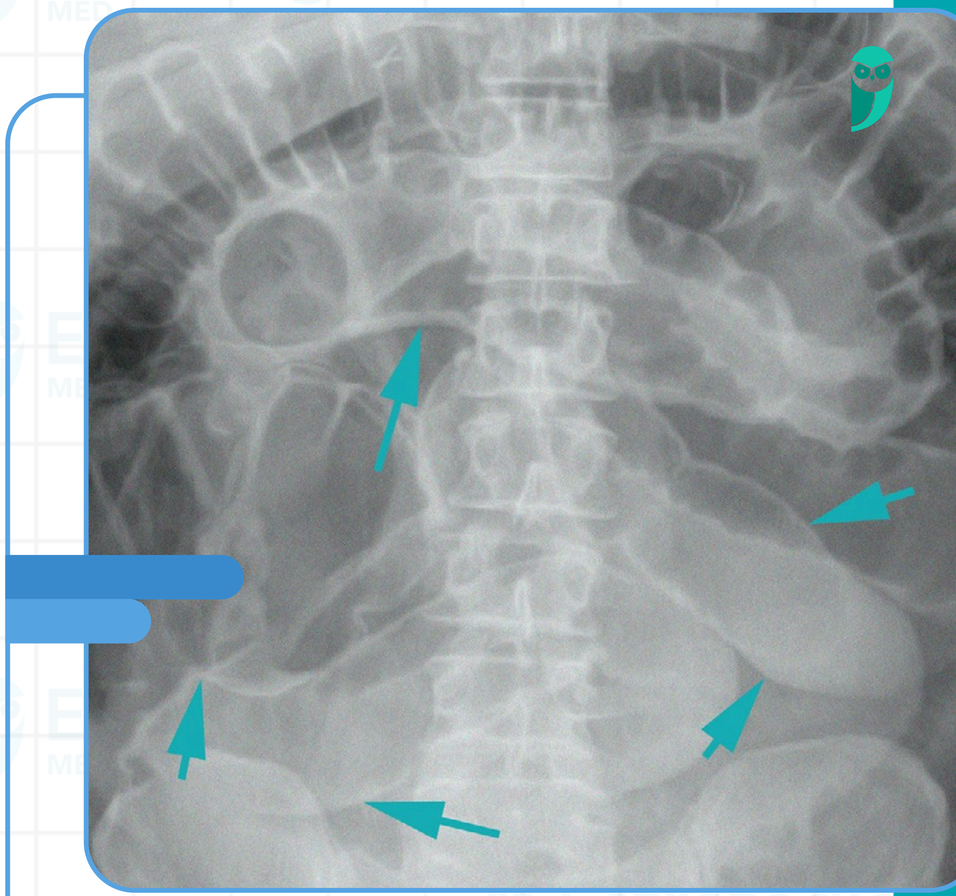
Abdome Agudo Obstrutivo

- Radiografia de tórax posteroanterior (PA) em pé (ortostase);
- Radiograma de abdome em pé e deitado (decúbito dorsal).

Flashcard

Pergunta

Qual é o sinal indicado nesta figura e de que ele é sugestivo?



Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Sinal de Rigler (ou sinal da parede dupla). É sugestivo de pneumoperitônio.

Pergunta

Flashcard

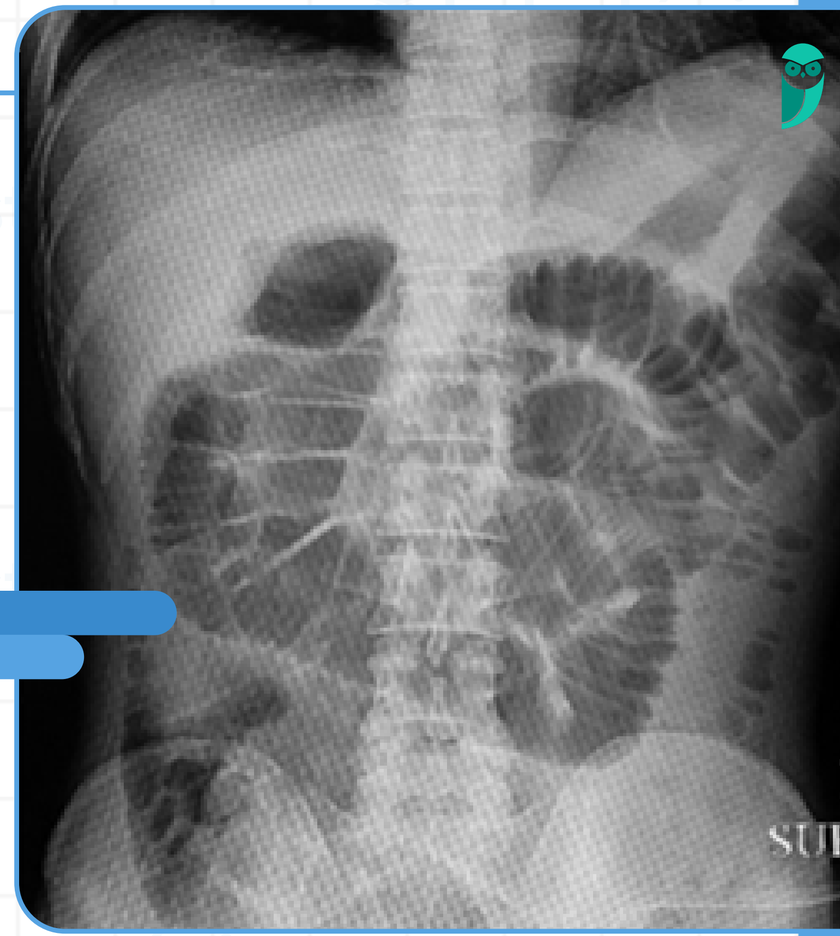
O que é o sinal do empilhamento de moedas?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

É um sinal em que se visualiza dilatação das alças do delgado e as pregas coniventes, sugerindo obstrução intestinal alta.



Pergunta

Flashcard

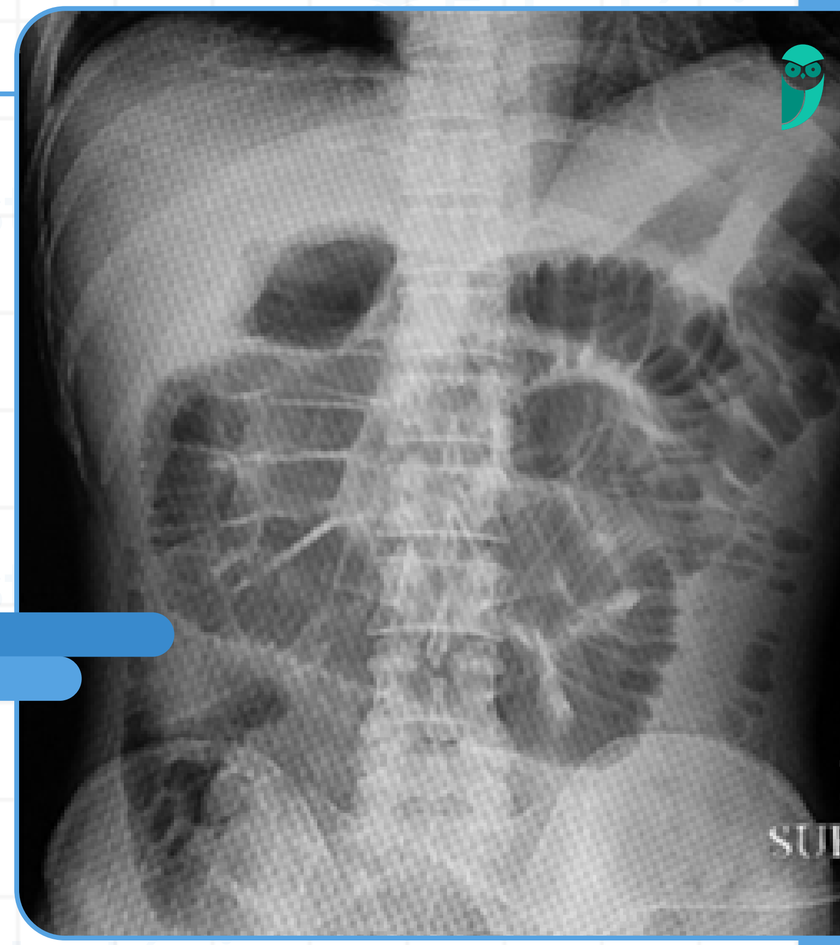
Quais são as características radiológicas gerais de uma obstrução intestinal alta?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Presença de níveis hidroaéreos, distensão gasosa intestinal com distribuição centralizada no abdome e visualização das pregas coniventes (empilhamento de moedas).



Pergunta

Flashcard

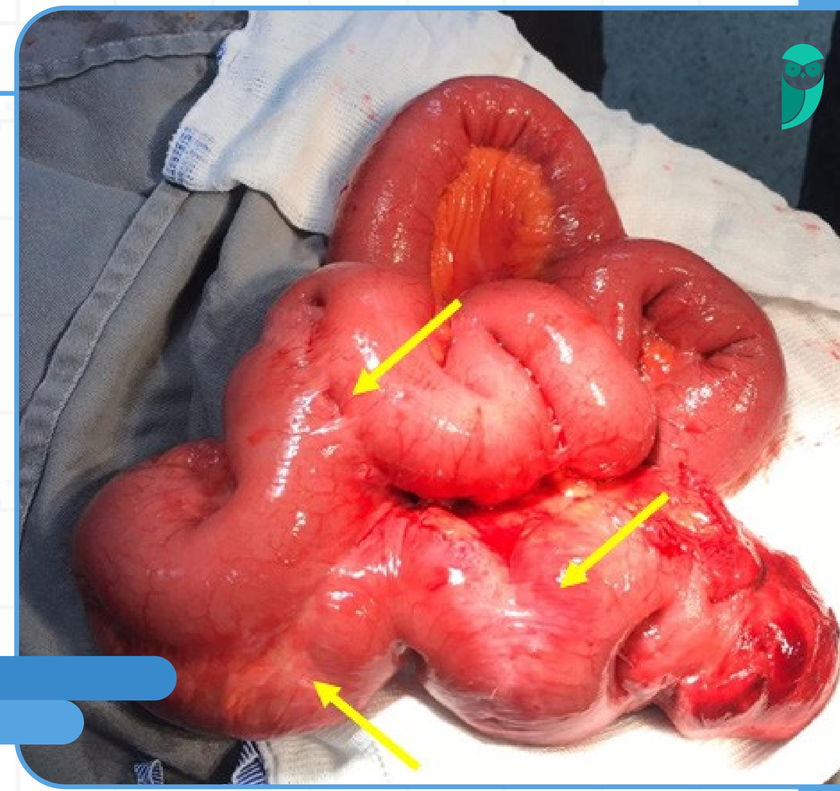
Quais são as duas principais causas de obstrução intestinal alta?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Aderências intestinais (bridas) e tumores metastáticos.



Pergunta

Flashcard

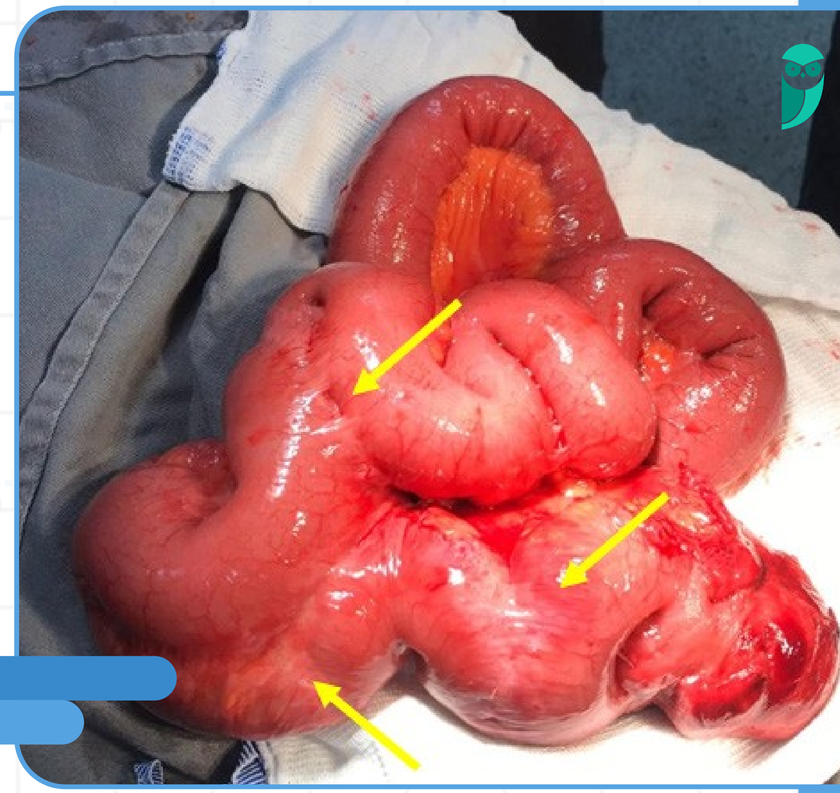
Qual é o principal fator de risco para a formação de bridas?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Cirurgias abdominais prévias.



Pergunta

Flashcard

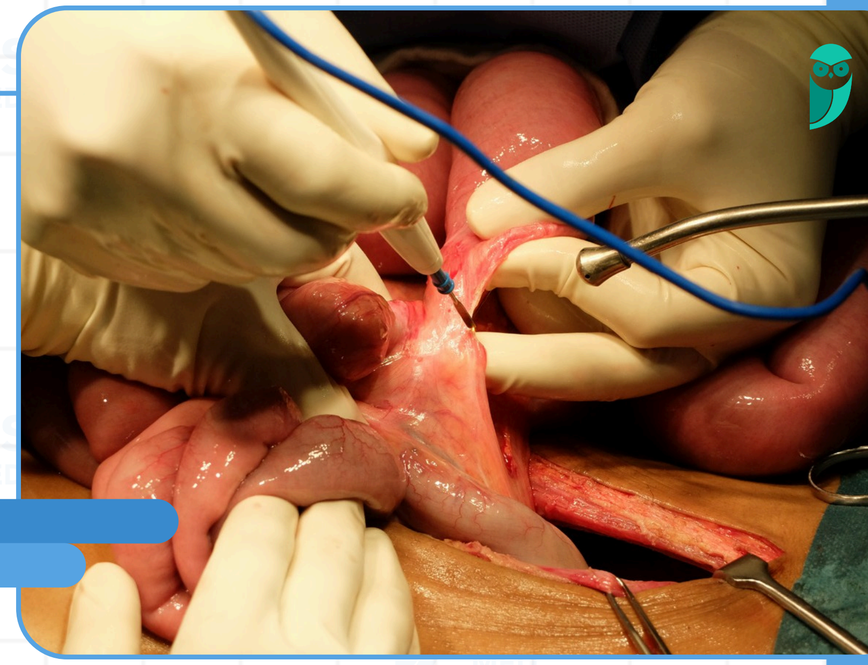
Diagnóstico provável: mulher de 45 anos apresenta distensão e dor abdominais, vômitos biliosos, parada de eliminação de fezes e flatos. Comorbidades: hipertensão e diabetes. Cirurgias prévias: colecistectomia aberta há 8 anos e cirurgia bariátrica há 4 anos.

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Obstrução intestinal proximal (provavelmente por bridas).



Pergunta

Flashcard

Em geral, qual é o tratamento inicial da obstrução intestinal por bridas?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Suporte clínico (p. ex.: descompressão gástrica e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos).

Pergunta

Flashcard

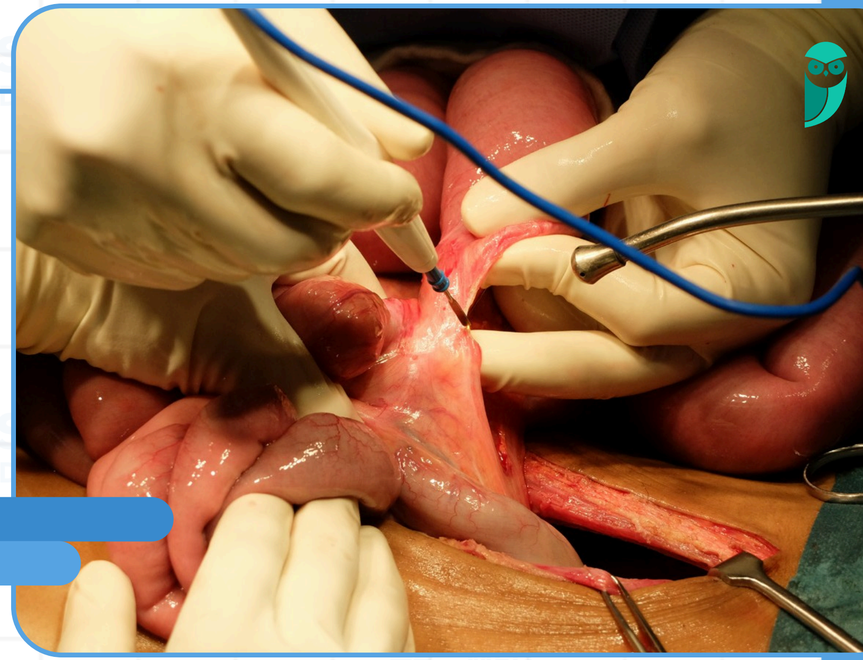
Quando indicamos tratamento cirúrgico para o manejo de pacientes com obstrução intestinal por bridas?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Quando não há resposta ao tratamento conservador ou quando há piora clínica (p. ex.: febre, piora da leucocitose, acidose metabólica, hipotensão e taquicardia), indica-se a laparotomia exploratória com lise das bridas.



Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento de escolha da hérnia agudamente encarcerada e com sinais de estrangulamento?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Inguinotomia direta de urgência sem redução da hérnia.

Pergunta

Flashcard

Qual é a tríade classicamente associada ao volvo gástrico?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Tríade de Borchardt (presente em 70% dos pacientes):

- Dor intensa e súbita no abdome superior;
- Vômitos severos;
- Incapacidade de passar uma sonda nasogástrica.

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável: homem de 60 anos apresenta dor no abdome superior, distensão abdominal e vômitos. A sonda nasogástrica não progride,apesar de várias tentativas.

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Volvo gástrico.

Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável: mulher de 70 anos queixa-se de dor e distensão abdominais, sem vômitos. Toque retal com fezes na ampola retal. Radiografia de abdome evidencia pneumobilia, cálculo radiopaco na fossa ilíaca direita e sinal do empilhamento de moedas.

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Íleo biliar.

Pergunta

Flashcard

Quais são os achados radiográficos típicos do íleo biliar (tríade de Riegler)?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

- Sinais de obstrução intestinal alta;
- Aerobilia;
- Cálculo biliar ectópico.



Pergunta

Flashcard

Qual é o principal fator de risco para a síndrome da artéria mesentérica superior?

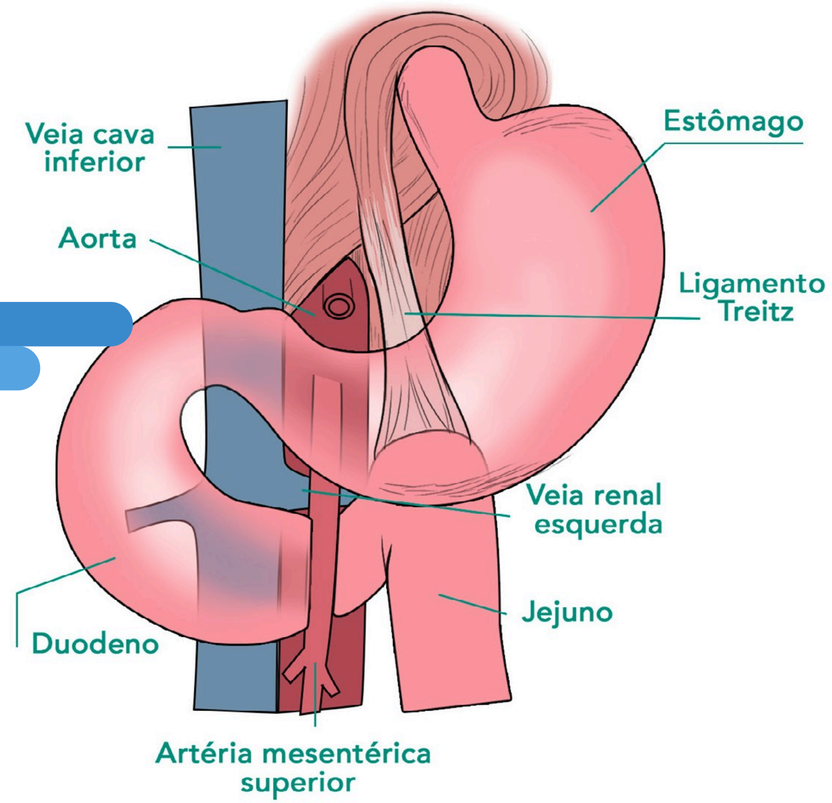
Cirurgia

Resposta

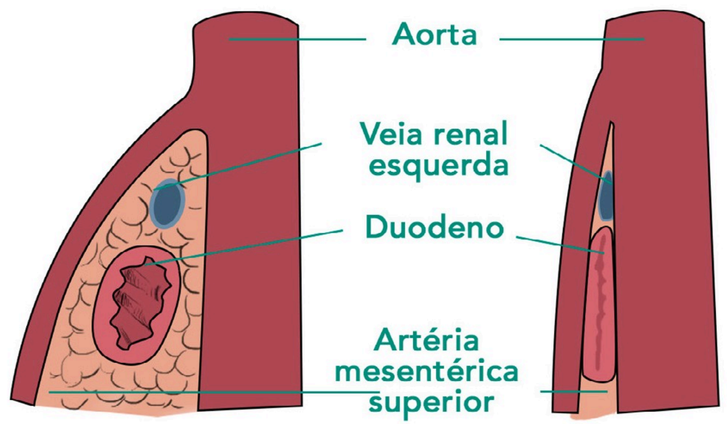
Abdome Agudo Obstrutivo

Perda de peso significativa.

Vista anterior



Vista lateral



Normal **Compressão duodenal**

Pergunta

Flashcard

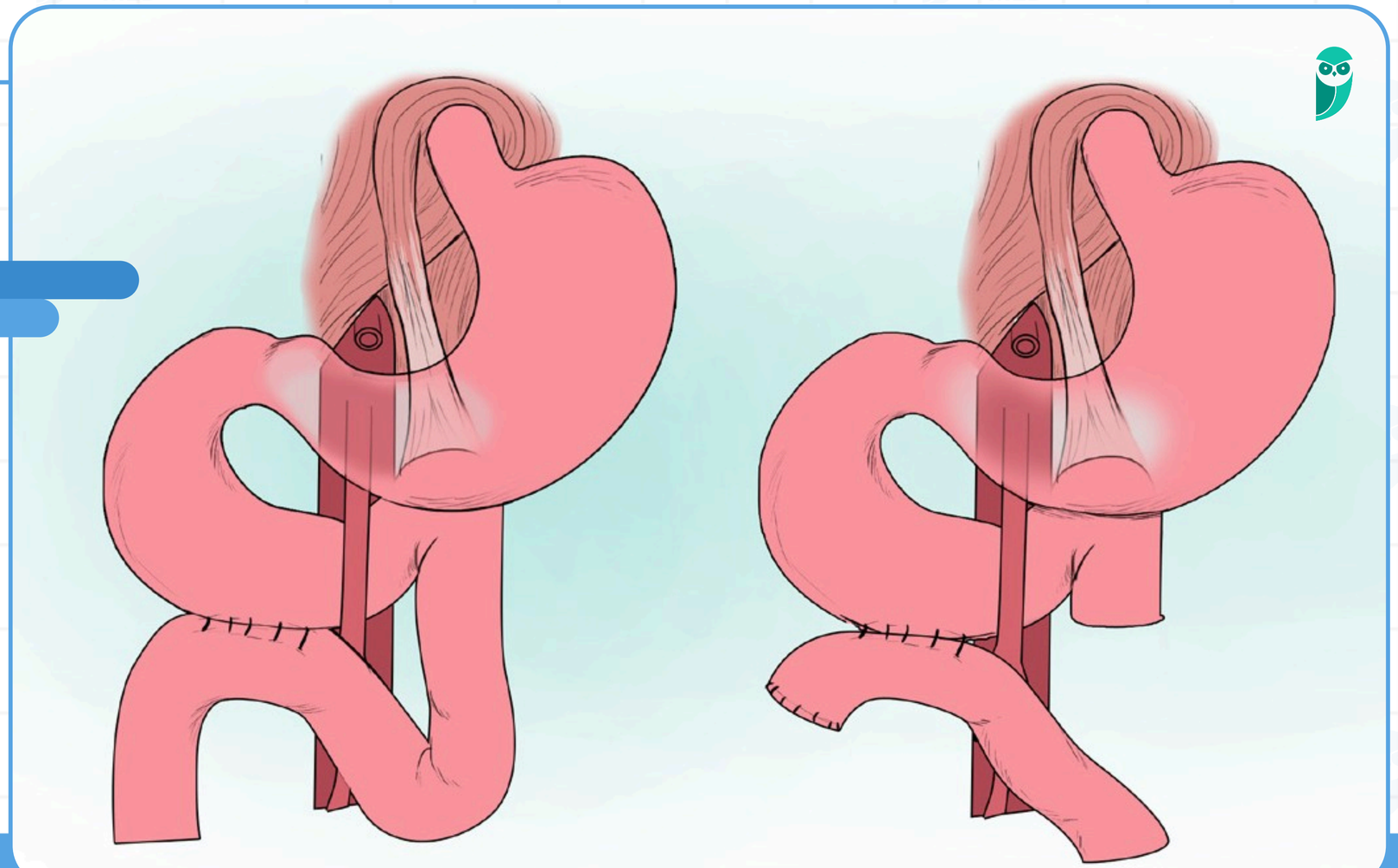
Qual é o tratamento de escolha da síndrome da artéria mesentérica superior?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Duodenojejunostomia.



Pergunta

Flashcard

Quais são as duas causas mais comuns de obstrução intestinal baixa?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

1. Câncer colorretal;
2. Volvo.

Pergunta

Flashcard

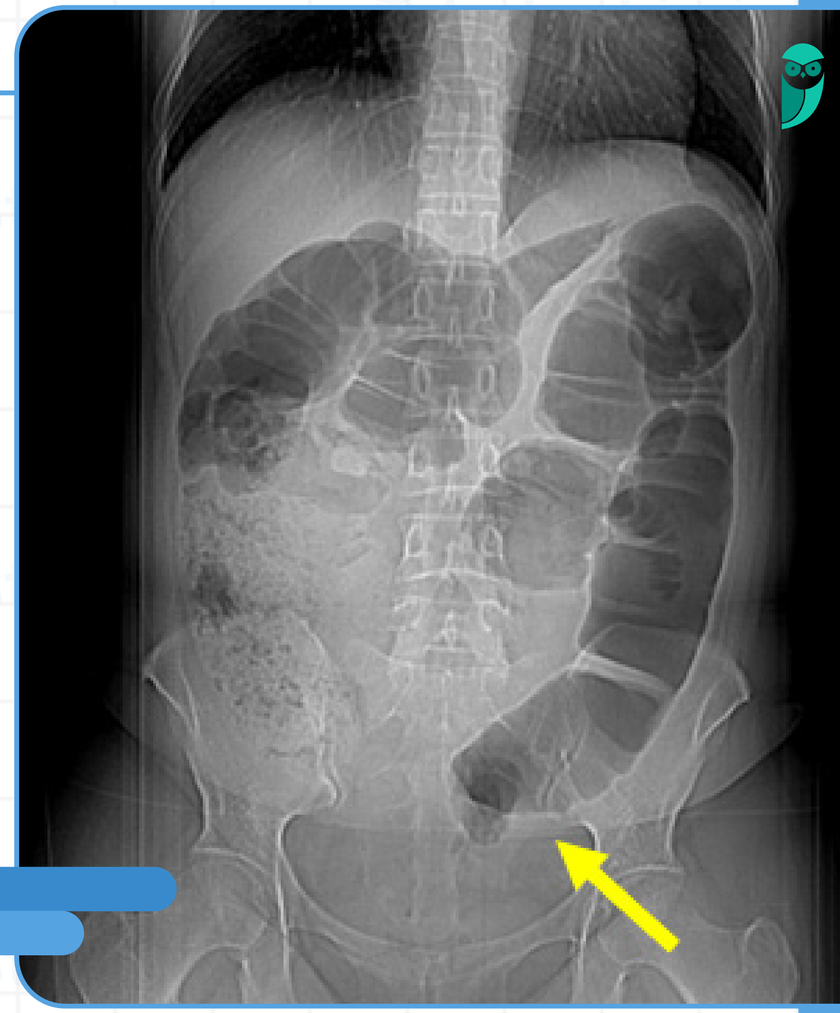
Quais são as características radiológicas gerais de uma obstrução intestinal baixa?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

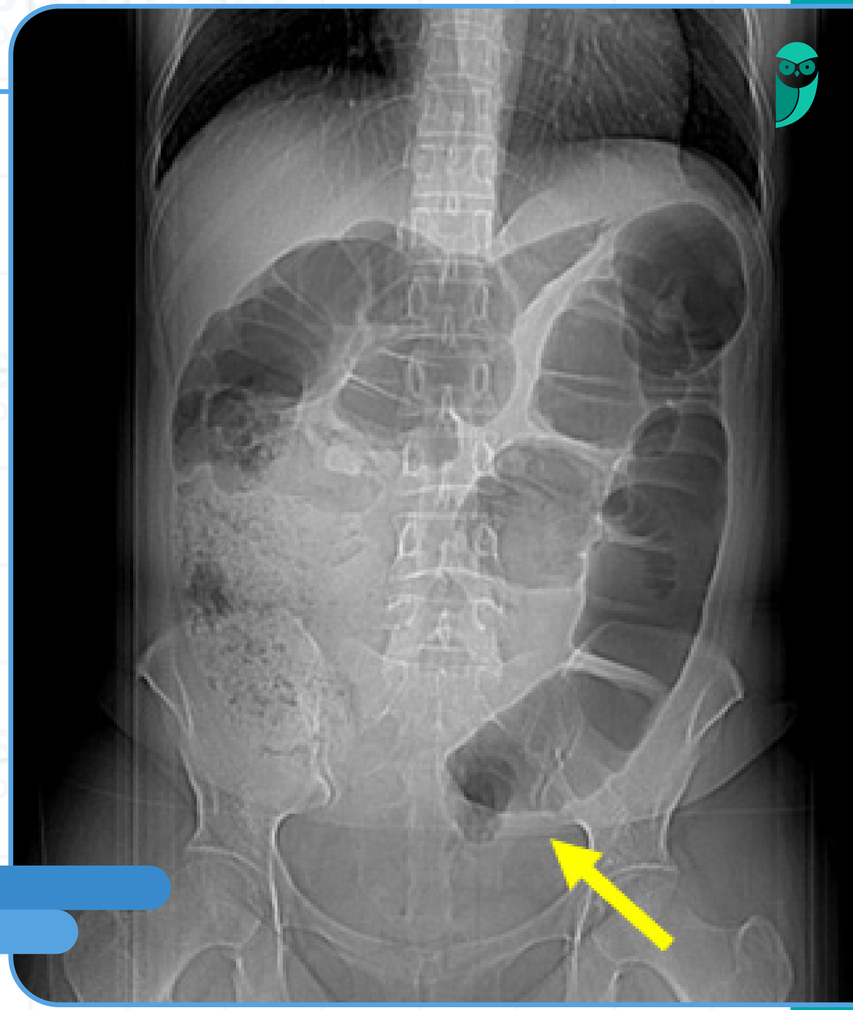
Visualização das haustrações colônicas, localização periférica no abdome e ausência de ar na ampola retal.



Flashcard

Pergunta

Diagnóstico provável: homem de 71 anos apresenta distensão abdominal, parada da eliminação de fezes e flato e dor em cólica. Nega vômitos e refere perda de 5 kg. Nega cirurgias abdominais prévias. Foi realizada radiografia de abdome.



Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Neoplasia colônica causando obstrução intestinal.

Flashcard

Pergunta

Qual é o nome do sinal indicado pela seta verde nesta figura e de que patologia ele é mais comumente sugestivo?



Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Sinal da “maçã mordida”, sugestivo de obstrução do lúmen do cólon (mais comumente por neoplasia colônica).

Pergunta

Flashcard

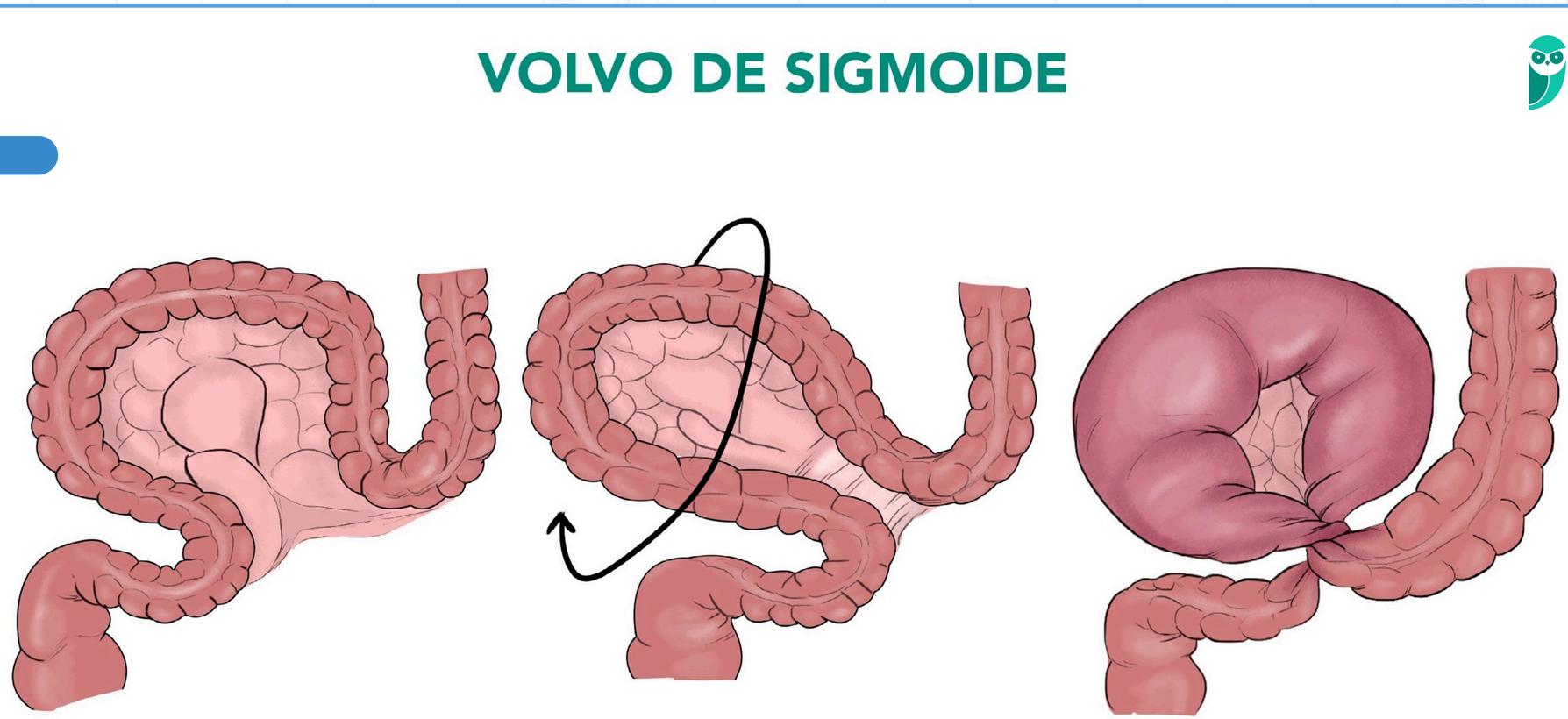
Qual é a localização mais comum dos volvos?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Cólon sigmoide (75% dos casos).



Pergunta

Flashcard

Diagnóstico provável: homem de 70 anos apresenta dor e distensão abdominais, náuseas e vômitos. Realizou a radiografia de abdome a seguir:



Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Volvo de sigmoide.

Pergunta

Flashcard

Qual é o sinal radiológico classicamente associado ao volvo de sigmoide?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Sinal do grão de café.



Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento do volvo de sigmoide no paciente estável hemodinamicamente e sem peritonite?

Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Abdome Agudo Obstrutivo

Colonoscopia ou retossigmoidoscopia descompressiva. Programar sigmoidectomia para a mesma internação.

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento do volvo de sigmoide no paciente instável ou com peritonite?

Cirurgia

Resposta

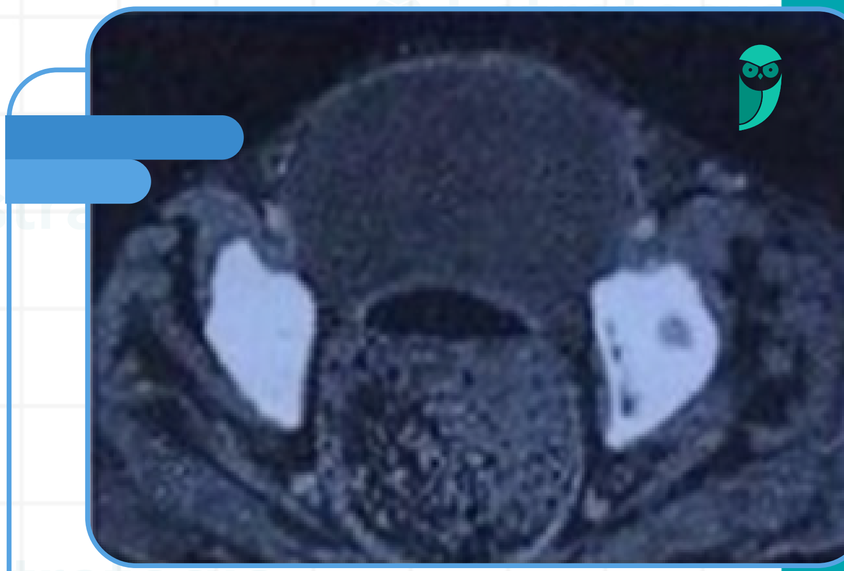
Abdome Agudo Obstrutivo

Laparotomia e cirurgia de Hartmann.

Flashcard

Pergunta

Diagnóstico provável: homem de 70 anos queixa-se de dor e distensão abdominais. Refere dificuldade para evacuar, mas nota passagem depequena quantidade de fezes líquidas. Está em bom estado geral, sem sinais de peritonite. Toque retal sem sinais de massas. Foi realizada uma tomografia de abdome.



Legenda: Imagem retirada da prova de acesso direto UFRJ 2013.

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Fecaloma.

Pergunta

Flashcard

Qual é o sinal radiológico classicamente associado ao fecaloma?

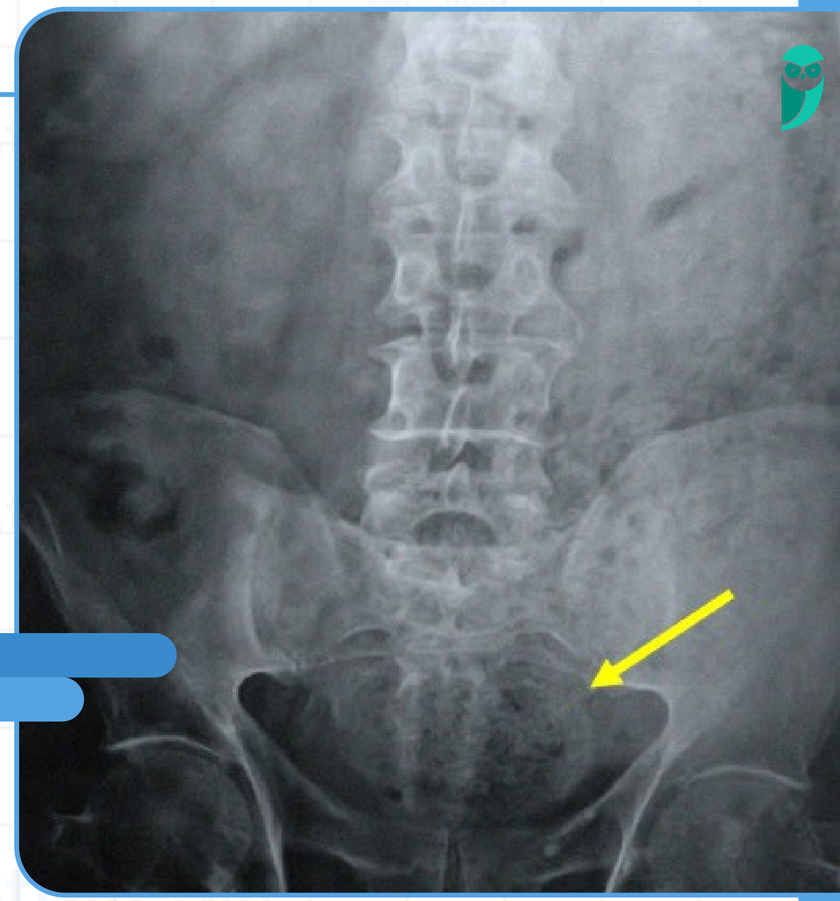
Cirurgia

Resposta

Estratégia MED

Abdome Agudo Obstrutivo

Sinal do “miolo de pão”.



Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento usual do fecaloma?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

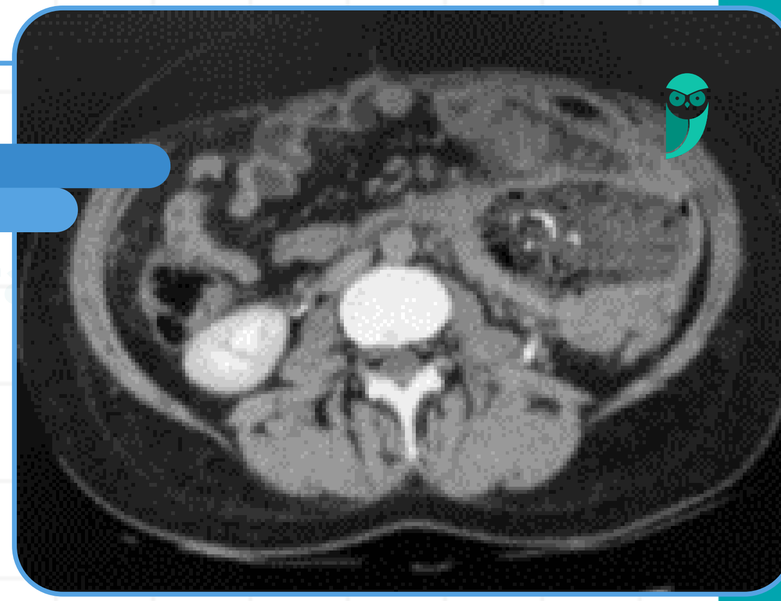
Desimpactação do fecaloma (pode ser manual, com o auxílio de enemas, laxantes ou até em centro cirúrgico).



Flashcard

Pergunta

Diagnóstico provável: mulher de 25 anos sofre acidente de moto a 80 km/h. Chega à emergência com sinais de fratura, sangramento, escoriações, hipotensão e rebaixamento do nível de consciência. É intubada e levada à laparotomia de emergência. É realizada cirurgia de controle de danos, com controle da hemorragia, empacotamento e fechamento temporário do abdome. Três meses após a alta, apresenta vômitos, distensão abdominal e dor abdominal.



Legenda: Retirada da prova do IAMSPE 2017.

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Corpo estranho (gossipiboma).

Flashcard

Pergunta

Diagnóstico provável: homem de 65 anos realizou colectomia e cirurgia de Hartmann devido a uma neoplasia de cólon. No 5º dia de pós-operatório apresenta náuseas e vômitos, intolerância à dieta oral, ausência de eliminação de fezes, além de distensão abdominal. É realizada uma radiografia que evidencia distensão universal das alças (delgado e cólon).



Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Íleo paralítico.

Flashcard

Pergunta

Diagnóstico provável: homem de 71 anos permanece em UTI para recuperação de um transplante cardíaco. Apresenta distensão abdominal não dolorosa, timpanismo à percussão, especialmente à direita, ruídos hidroaéreos presentes e parada de eliminação de fezes. Toque retal com fezes sólidas. Radiografia evidencia distensão importante do cólon direito.



Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Pseudo-obstrução colônica.

Pergunta

Flashcard

Qual é o diâmetro cecal considerado limítrofe para um maior risco de perfuração nos pacientes com pseudo-obstrução colônica?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

Diâmetro cecal ≥ 12 cm.

Pergunta

Flashcard

Qual é o tratamento usual da pseudo-obstrução colônica de acordo com a dilatação cecal?

Cirurgia

Resposta

Abdome Agudo Obstrutivo

- Ceco < 12 cm e paciente estável: medidas de suporte (jejum, hidratação, sonda nasogástrica, etc);
- Ceco ≥ 12 cm ou pacientes instáveis: neostigmina inicialmente, seguida de colonoscopia descompressiva.